

Morfología y distribución de las lesiones cutáneas

1. Introducción y relevancia clínica

La **morfología y distribución de las lesiones cutáneas** son pilares del razonamiento diagnóstico dermatológico.

Una descripción adecuada de la piel no se limita a “qué lesión es”, sino también a **cómo está dispuesta, dónde se localiza, cuántas hay y cómo evolucionan**.

Estos elementos permiten **reconocer patrones clínicos característicos** de diversas enfermedades dermatológicas y sistémicas, facilitando la orientación etiológica sin necesidad de exámenes complementarios inmediatos.

Por ejemplo:

- Un patrón **dermatomal vesicular** sugiere **herpes zóster**.
- Lesiones **simétricas en pliegues** orientan a **psoriasis inversa o dermatitis seborreica**.
- Lesiones **centrífugas y anulares** hacen pensar en **tiña o eritema multiforme**.

El examen dermatológico, cuando se ejecuta con método y lenguaje técnico, tiene **alta sensibilidad y especificidad diagnóstica**. Por ello, dominar la **morfología y distribución** de las lesiones es **indispensable para el EUNACOM** y para la práctica clínica general.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Conceptos básicos

La **morfología** describe las **características visibles y palpables** de una lesión (forma, color, superficie, borde, consistencia).

La **distribución y patrón de disposición** describen **cómo y dónde** se agrupan o localizan esas lesiones en el cuerpo.

Estas características derivan de la **respuesta anatómica y fisiopatológica** del tejido cutáneo ante estímulos inflamatorios, infecciosos, inmunológicos o neoplásicos.

2.2. Factores determinantes de la morfología

- 1. **Localización anatómica** (piel gruesa o delgada, seborreica o seca).
- 2. **Causa subyacente** (infecciosa, inflamatoria, autoinmune, neoplásica).
- 3. **Profundidad del proceso** (epidérmico → vesícula; dérmico → pápula o nódulo).
- 4. **Tipo de respuesta inmunológica** (alérgica, linfocítica, neutrofílica).
- 5. **Tiempo de evolución** (aguda → eritema; crónica → liquenificación, descamación).

3. Clínica: signos, patrones y diagnóstico diferencial

3.1. Morfología de las lesiones cutáneas

A. Según forma y contorno

Morfología	Descripción	Ejemplo clínico característico
Anular	Lesión circular con centro claro y borde activo	Tiña corporis, eritema multiforme
Arciforme	Forma de arco o semicírculo	Urticaria, eritema marginado reumático
Numular (en moneda)	Redonda, bien delimitada, de tamaño uniforme	Eccema numular
Serpiginosa	Bordes irregulares, sinuosos o que avanzan en patrón migratorio	Larva cutánea migrans
Lineal	Disposición en línea o trayecto	Dermatitis de contacto, excoriaciones, liquen estriado

Blanda	Se deprime fácilmente	Lipoma
Firme / dura	No deformable; más rígida	Nódulo de carcinoma basocelular
Fluctuante	Contiene líquido (pus o exudado)	Absceso, quiste epidérmico
Indurada	Espesamiento inflamatorio profundo	Celulitis, erisipela

D. Según borde y límite

Tipo de borde	Descripción	Ejemplo
Netos / definidos	Cambio abrupto entre piel sana y enferma	Psoriasis, tiña
Difusos / mal definidos	Transición progresiva	Dermatitis atópica, lupus eritematoso
Sobreelevados	Por edema o proliferación celular	Urticaria, liquen plano

E. Según color

Color	Mecanismo	Ejemplo
Eritematoso	Vasodilatación e inflamación	Ecceema, erisipela
Violáceo	Congestión o hemorragia dérmica	Púrpura, vasculitis

Hipopigmentado	Disminución de melanina	Vitiligo, pitiriasis alba
Hiperpigmentado	Aumento de melanina	Melasma, postinflamatorio
Amarillento	Acúmulo de lípidos o bilirrubina	Xantomas, ictericia
Negro / azul oscuro	Melanina profunda o necrosis	Melanoma, gangrena

3.2. Distribución anatómica de las lesiones

La **distribución corporal** es una de las claves diagnósticas más relevantes. Determinadas enfermedades tienen **patrones topográficos característicos**.

Patrón de distribución	Descripción	Ejemplos clínicos
Simétrica bilateral	Afecta ambos lados del cuerpo de forma similar	Psoriasis, dermatitis seborreica, lupus eritematoso
Asimétrica	Lesiones aisladas o agrupadas sin simetría	Tiña corporis, eritema multiforme
Zosteriforme (dermatomal)	Siguen trayecto nervioso unilateral	Herpes zóster
Extremidades	Predominio en brazos o piernas	Eccema dishidrótico, dermatitis de contacto
Palmo-plantar	Piel gruesa, lesiones hiperqueratósicas o pustulosas	Psoriasis palmoplantar, sífilis secundaria

Flexural (intertriginosa)	En pliegues (axilas, ingles, cuello, submamario)	Dermatitis seborreica, candidiasis intertriginosa
Extensora	En superficies externas de extremidades	Psoriasis vulgar
Centrofacial	Zona T de la cara (nariz, frente, mentón)	Rosácea, acné
Generalizada	Compromete >90% de la superficie corporal	Eritrodermia, escarlatina, reacción medicamentosa
Fotosensible (fotoexpuesta)	Áreas expuestas al sol	Lupus, porfiria cutánea tarda

3.3. Disposición o patrón de agrupación

Patrón	Descripción	Ejemplo clínico
Aislada (solitaria)	Lesión única	Queratoacantoma, nódulo basal
Agrupada (herpetiforme)	Lesiones vesiculares en racimos	Herpes simple
Confluente	Varias lesiones que se fusionan	Psoriasis, dermatitis numular
Diseminada	Lesiones múltiples distribuidas ampliamente	Varicela, sarampión

Anular con crecimiento centrífugo	Borde activo que se expande	Tiña, eritema anular
Reticulada (en red)	Conexiones lineales o vascularizadas	Livedo reticularis
Folicular	Centrada en el ostium piloso	Foliculitis, queratosis pilaris

3.4. Diagnóstico diferencial basado en patrón morfológico

Patrón	Diagnóstico sugerido
Vesicular agrupado	Herpes simple / zóster
Placas eritematoescamosas simétricas	Psoriasis vulgar
Máculas hipocrómicas en tronco	Pitiriasis versicolor
Lesiones anulares con borde activo	Tiña corporis
Pápulas liquenoides violáceas	Liquen plano
Exantema máculo-papular difuso	Fármacos, sarampión, virus
Lesiones costrosas melicéricas	Impétigo

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El examen clínico es **el principal método diagnóstico**; sin embargo, ciertas herramientas aumentan la precisión:

Examen	Aplicación	Utilidad
Dermatoscopía	Lesiones pigmentadas o vasculares	Diferencia benignas vs malignas
Luz de Wood	Pigmentación o infecciones fúngicas	Resalta fluorescencia
Biopsia cutánea	Lesiones persistentes, infiltradas o neoplásicas	Confirmación histológica
Raspado KOH / Gram / Giemsa	Lesiones escamosas, pustulosas o ulceradas	Identificación del agente etiológico
Vitropresión	Diferencia eritema vs púrpura	Diagnóstico rápido de lesiones vasculares

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El tratamiento depende de la **etiología**, pero un abordaje general basado en la morfología y distribución incluye:

1. **Medidas generales de cuidado cutáneo:**

- Higiene con jabones neutros.

- Hidratación diaria.
- Evitar rascado o manipulación de lesiones.
- Uso de **fotoprotección**.

2. Terapia tópica:

- Corticoides tópicos para lesiones inflamatorias localizadas.
- Antibióticos tópicos (mupirocina, ácido fusídico) si hay sobreinfección.
- Antimicóticos o antivirales tópicos según agente causal.

3. Terapia sistémica:

- Antihistamínicos orales para prurito.
- Corticoides sistémicos o inmunomoduladores en dermatitis generalizada.
- Fototerapia o inmunosupresores en psoriasis extensa o liquen plano severo.

4. Derivación especializada:

- Lesiones ulceradas, pigmentadas irregulares o refractarias deben ser **biopsiadas** o evaluadas por dermatología.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones

- **Diagnóstico tardío o incorrecto**, por mala descripción morfológica.
- **Infección secundaria** por manipulación o rascado.
- **Cicatrices o discromías** postinflamatorias.
- **Cronificación** (liquenificación, fibrosis) por inflamación sostenida.

Pronóstico

Excelente si el diagnóstico es precoz y el tratamiento se ajusta a la morfología y etiología.

Las lesiones diseminadas o ulceradas requieren estudio más profundo para descartar causas sistémicas.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. Describir siempre **tipo de lesión + color + tamaño + distribución + evolución**.
2. **Lesiones anulares con borde activo** → **tiña**; **con centro necrótico** → **eritema multiforme**.
3. **Simetría = enfermedad inflamatoria**; **asimetría = infecciosa o tumoral**.
4. **Zonas seborreicas (cara, tórax, espalda)** → dermatitis seborreica.
5. **Zonas extensoras** → **psoriasis**; **zonas flexurales** → **eczema atópico**.
6. **Vitropresión** es la herramienta más útil para diferenciar eritema de púrpura.
7. **Herpes zóster** siempre respeta la línea media corporal.



Errores comunes

- Usar términos inespecíficos (“ronchas”, “heridas”, “granitos”).
- Omitir descripción de **distribución y patrón** (crítico en el examen).
- Confundir lesiones primarias y secundarias.
- No correlacionar el patrón topográfico con diagnóstico clínico.
- Tratar empíricamente sin diagnóstico morfológico preciso.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **morfología y distribución** de las lesiones son esenciales para el diagnóstico dermatológico.
2. Las lesiones pueden describirse según **forma, superficie, borde, consistencia y color**.
3. Los **patrones de distribución** (simétrica, lineal, zosteriforme, flexural, extensora) orientan la etiología.
4. La **vitropresión, dermatoscopia y biopsia** son herramientas complementarias clave.
5. La **simetría y localización anatómica** son pistas diagnósticas fundamentales.
6. El examen debe incluir **tipo, número, tamaño, forma, color, superficie y disposición**.
7. Un lenguaje morfológico preciso y técnico es indispensable para aprobar el **EUNACOM** y ejercer clínica dermatológica segura.